

«Негоспітальна пневмонія»

Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- в'яснити анамнез захворювання та життя;
- продемонструвати практичну навичку “Аускультация легень”;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

11. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернувся чоловік.

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>	<i>Текст стандартизованого пацієнта</i>
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікарка-терапевт, Людмила Іванівна. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу обстеження.	Добре
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Володимир Миколайович
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	40 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Я працюю слюсарем.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Володимире Миколайовичу, що Вас турбує?	Кашель
	Можете розповісти про характер кашлю. Кашель з виділенням мокротиння чи без виділення мокротиння?	Так, звісно. Кашельіз гнійним мокротинням
	Вас турбує задишка?	Так
	Ви відчуваєте задишку під час фізичного навантаження чи в	Я відчуваю задишку тільки при фізичному

	стані спокою?	навантаженні
	Чи підвищувалася у Вас температура тіла протягом останніх днів? Розкажіть більш детально, яка була температура тіла?	У мене підвищувалася температура тіла до 39 ⁰ C протягом останніх днів, яка знижувалася до 37 ⁰ C після прийому парацетамолу та ібупрофену.
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Як давно Ви хворієте?	Все почалося останні 5 днів.
	З чим пов'язуєте?	Мабуть, зпереохолодженням, але я не впевнений.
	Розкажіть, більш детально, що трапилося з Вами п'ять днів назад?	Погода змінилася, стало дуже холодно. Я не одяг теплий одяг і я відчув сильний холод у всьому тілі. Після цієї події я захворів.
	Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?	Останні 2 дні, у мене тримається температура тіла до 37 ⁰ C, з'явився біль в грудній клітині при кашлі, посилилась задишка при ходьбі. Ліки мені не допомагають.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет, виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки?	Ні
	Операції, травми протягом життя? Шкідливі звички?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	Ні
	Спадковість: чи хтось у сім'ї хворів хронічними захворюваннями?	Ні
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба, я проведу Вам аускультацию легень	Так, зараз.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		

Обробити акустичну мембрану фонендоскопу розчином антисептика		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА		
Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді		
<i>Провести аускультацию легень</i>	Аускультация легень: симетричність (аускультацию проводити на симетричних ділянках грудної клітки, у кожній точці аускультції вислуховувати 2-3 дихальних цикли).	
	Аускультация легень: коректна послідовність спереду (у місці розташування серця легені не вислуховувати)	
	Аускультация легень: коректна послідовність в пахвинних ділянках (при аускультції в бічних відділах просять хворого поставити руки на пояс)	
	Аускультация легень: коректна послідовність позаду (при вислуховуванні ззаду просять злегка нахилитися вперед і схрестити руки на грудях (для розбіжності лопаток)	
	Аналіз основних та побічних дихальних шумів: при аускультції легень у нижніх відділах ліворуч - дихання послаблене, вислуховуються дрібнопухирцеві хрипи.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Як Ви себе відчуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так.
	Володимире Миколайовичу, враховуючи, що у Вас є кашель, температура і аускультативні зміни в легенях, раджу Вам подальше дообстеження для встановлення заключного діагнозу і призначення ліків.	
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – синдром легеневої інфільтрації.	Що робити?
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Спочатку хочу наголосити на тому, що крім регулярного	Дякую, лікарю

	прийому ліків, треба відкоригувати спосіб життя: виконувати регулярні дихальні вправи, прогулянки на свіжому повітрі, заборонено спортивне та екстремальне фізичне навантаження, паління, прийом алкоголю. Слід дотримуватися здорового харчування та відпочинку.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Володимире Миколайовичу, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозумів
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.

12. Інструкція для стандартизованого пацієнта:

Ви – чоловік, Володимир Миколайович, 40 років, слюсар. Ви звернулися до лікаря терапевтичного відділення.

Скарги: на кашель зі слизово-гнійним мокротинням, підвищення температури тіла до 39°C, помірну задишку при фізичних навантаженнях, біль в грудній клітці при кашлі, загальну слабкість.

Анамнез захворювання: вважає себе хворим протягом п'яти діб, коли після переохолодження з'явилися вищевказані скарги. Приймав парацетамол, ібупрофен із незначним поліпшенням стану.

Анамнез життя: туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет, виразкову хворобу шлунку та 12-ти палої кишки заперечує. Протягом життя хворів на ГРВІ. Операції, травми протягом життя – заперечує. Алергійні реакції та непереносимість ліків – заперечує. Спадковість не обтяжено.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості. Шкірні покриви чисті, блідо-рожеві. Температура тіла 38,2°C. Периферичних набряків немає. При аускультатії у нижніх відділах ліворуч дихання послаблене, вислуховуються дрібнопухирцеві хрипи. ЧДР – 21 за хвилину. SpO₂ 97 %. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС=Пульс=92 за хв., АТ_{на обох руках} 120/70 мм рт.ст. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Сценарій-відповіді стандартизованого пацієнта у п.11.